

CAPÍTULO 8.1

Trastornos Digestivos Funcionales

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Gastroenterología

La gastroenterología es un pilar fundamental del examen EUNACOM, aportando aproximadamente **10 preguntas** de la sección de Medicina Interna. La mayoría de estas preguntas no presentan una complejidad extrema, pero requieren que el médico sea capaz de distinguir con precisión entre patologías funcionales y orgánicas.

El primer paso para abordar cualquier motivo de consulta digestivo es diferenciar los **Trastornos Digestivos Funcionales (TDF)** de las patologías estructurales o malignas mediante la identificación sistemática de los **signos de alarma**.

Trastornos Digestivos Funcionales (TDF)

Los TDF son la causa más frecuente de consulta gastroenterológica a nivel global. Se definen por la presencia de síntomas crónicos o recurrentes que no pueden explicarse por anomalías estructurales o bioquímicas detectables por pruebas de rutina.

- **Prevalencia:** Son la primera causa de **Diarrea Crónica**, dolor abdominal crónico y constipación crónica.
- **Diagnóstico:** Es **absolutamente clínico**. No se requiere (ni se debe) realizar una batería exhaustiva de exámenes si el paciente cumple los criterios y no presenta signos de alarma.
- **Manejo General:**
 - 1. **Educación:** Explicar la naturaleza benigna de la enfermedad (descartar cáncer activamente en la conversación).
 - 2. **Manejo del Estrés:** Los síntomas suelen exacerbarse con factores psicosociales.
 - 3. **Farmacoterapia:** Dirigida al síntoma predominante (dolor, diarrea o constipación).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de lo funcional: Los TDF se entienden hoy como trastornos del **eje cerebro-intestino**. Existe una hipersensibilidad visceral (el paciente siente dolor ante estímulos que para otros son normales) y alteraciones en la motilidad gastrointestinal, a menudo gatilladas por estrés, dieta o disbiosis.

Signos de Alarma en Gastroenterología

La presencia de cualquier signo de alarma obliga al médico a abandonar la sospecha de un trastorno funcional y proceder con un estudio orgánico, generalmente mediante **Endoscopia Digestiva Alta (EDA)** o **Colonoscopia**, dependiendo de la localización sospechada del síntoma.

Para memorizarlos, utilizamos la regla del **ABC...N**:

TABLA 8.1.1: LETRA VS SIGNO DE ALARMA

LETRA	SIGNO DE ALARMA	SIGNIFICADO / SOSPECHA CLÍNICA
A	Anemia / AINES	Anemia ferropénica sugiere sangrado oculto (Cáncer de Colon o Gástrico). Uso de AINES sugiere Úlcera Péptica .
B	Baja de peso	Involuntaria y significativa; altamente sospechosa de neoplasia.
C	Cambio en los síntomas	Un paciente con síntomas crónicos que cambia su patrón habitual (ej. dolor que ahora lo despierta).
D	Disfagia	Dificultad para tragar; obliga a descartar cáncer de esófago.
E	Edad > 50 años	El inicio de síntomas digestivos después de los 50 años siempre es signo de alarma.
F	Familiares con Cáncer	Antecedentes de primer grado de cáncer digestivo aumentan el riesgo basal.
G	Gastroduodenal (Antecedente)	Historia previa de úlcera péptica (riesgo de recurrencia o complicaciones).
H	Hemorragias	Hematemesis, melena, hematoquecia o rectorragia.
N	Nocturnos (Síntomas)	Dolor o diarrea que despiertan al paciente durante la noche (lo funcional "duerme").

Otros signos de sospecha orgánica:

- **Fiebre:** Sugiere infección o **Enfermedad Inflamatoria Intestinal**. - **Lientería:** Presencia de alimentos no digeridos en las deposiciones (sugiere malabsorción). - **Esteatorrea:** Deposiciones con gotas de grasa, aceitosas o que flotan (sugiere insuficiencia pancreática o malabsorción). - **Pujo y Tenesmo:** Orientan a patología rectal (infecciosa o **Colitis Ulcerosa**).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave: - **Pujo:** Ganas frecuentes de defecar con esfuerzo. - **Tenesmo:** Sensación de evacuación incompleta (querer seguir defecando después de haber terminado).

Síndrome de Intestino Irritable (SII)

El SII es el TDF más representativo. Se caracteriza por la asociación de dolor abdominal y alteraciones en el hábito evacuatorio.

Criterios Diagnósticos (Roma)

Para el diagnóstico clínico se requiere **Dolor Abdominal Crónico** más al menos dos de los siguientes puntos: 1. Cambio en la **consistencia** de las deposiciones (Diarrea o Constipación). 2. Cambio en la **frecuencia** de las deposiciones. 3. El dolor **disminuye con la evacuación** (ya sea de gases o deposiciones).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El diagnóstico de SII **no es un diagnóstico de descarte**. Es un diagnóstico clínico basado en criterios positivos. Solo pedimos exámenes adicionales (como colonoscopia) si existen signos de alarma.

Tratamiento Farmacológico según Fenotipo

El tratamiento se ajusta según el síntoma que más afecta la calidad de vida del paciente:

TABLA 8.1.2: FENOTIPO VS FÁRMACO DE ELECCIÓN

FENOTIPO	FÁRMACO DE ELECCIÓN	MECANISMO / RAZÓN
Predominio Diarrea	Antidepresivos Tricíclicos (ej. Amitriptilina a dosis bajas)	Tienen efecto anticolinérgico (estriñen) y modulan el dolor visceral.
Predominio Constipación	Trimebutina	Modulador de la motilidad gastrointestinal; ayuda a regular el tránsito.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Un "recurso nemotécnico" para recordar los síntomas del SII: En Chile, el **SII** (Servicio de Impuestos Internos) también causa dolor abdominal, diarrea y constipación a los contribuyentes. ¡No lo olvides para el examen!

Algoritmo de Conducta Clínica

- **Paciente consulta por dolor abdominal o cambio de hábito:**
- **¿Tiene Signos de Alarma? (ABC...N):**
 - - **SÍ:** Derivar a estudio endoscópico (EDA si es alto, Colonoscopia si es bajo).
- - **NO:** Aplicar criterios de SII.
- **¿Cumple criterios de SII?**
 - - **SÍ:** Iniciar manejo funcional (Educación + Dieta + Fármaco según síntoma).
 - - **NO:** Reevaluar otras causas funcionales (Dispepsia funcional, etc.).

NOTA CLÍNICA

Recuerda que si un paciente tiene SII diagnosticado desde la juventud y a los 60 años sus síntomas cambian o aparece anemia, el diagnóstico funcional ya no es suficiente y se debe re-estudiar como si fuera un caso nuevo con signos de alarma.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 32 años consulta por dolor abdominal recurrente en hipogastrio de 8 meses de evolución, que alivia tras la defecación y se asocia a períodos alternados de diarrea y constipación. Sin baja de peso, sin rectorragia ni anemia. Examen físico y hemograma normales."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Síndrome de Intestino Irritable (Criterios de Roma IV): dolor abdominal recurrente al menos 1 día por semana en los últimos 3 meses, asociado a ≥ 2 criterios: relacionado con la defecación, cambio en la frecuencia o en la forma de las heces. En ausencia de banderas rojas (edad > 50 años, anemia, rectorragia, baja de peso, fiebre, historia familiar de CCR), el manejo es con cambios dietéticos (FODMAPs), antiespasmódicos (Trimebutina/Mebeverina) y probióticos.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los trastornos digestivos funcionales son la primera causa de consulta gastroenterológica, diarrea crónica, dolor abdominal crónico y constipación crónica
- El diagnóstico de trastornos digestivos funcionales es clínico; lo fundamental es buscar signos de alarma
- Los signos de alarma (ABC) incluyen: anemia, baja de peso, cambio en síntomas, disfagia, edad >50 años, familiar con cáncer, antecedente de úlcera, hemorragias y síntomas nocturnos
- Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopia o colonoscopia para descartar cáncer
- El SII requiere dolor abdominal crónico + al menos 2 de: cambio en consistencia, cambio en frecuencia, alivio con evacuación
- El diagnóstico de SII es clínico con criterios positivos, NO es de descarte
- El tratamiento del SII incluye educación, manejo del estrés y fármacos según predominio (amitriptilina para diarrea, trimebutina para constipación)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DIGESTIVOS FUNCIONALES)

PREGUNTA 1

Paciente de 35 años consulta por dolor abdominal crónico tipo cólico que alivia con la defecación, asociado a alternancia de diarrea y constipación, sin baja de peso ni fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Enfermedad inflamatoria intestinal
- B)** Cáncer de colon
- C)** Síndrome de intestino irritable
- D)** Enfermedad celíaca
- E)** Colitis ulcerosa

PREGUNTA 2

Paciente de 62 años con antecedentes de dolor abdominal crónico tipo funcional desde los 40 años consulta porque hace 2 meses el dolor lo despierta en la noche y ha bajado 4 kg de peso. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Iniciar amitriptilina
- B)** Realizar colonoscopia
- C)** Indicar trimebutino
- D)** Educar sobre manejo del estrés
- E)** Solicitar test de hidrógeno espirado

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para un paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea?

- A)** Omeprazol
- B)** Loperamida
- C)** Amitriptilina en dosis baja
- D)** Trimebutino
- E)** Metoclopramida

RESUMEN: TRASTORNOS DIGESTIVOS FUNCIONALES

Clase introductoria de gastroenterología que aborda los trastornos digestivos funcionales, en particular el síndrome de intestino irritable (SII). Estos trastornos son la primera causa de consulta gastroenterológica y de diarrea crónica, dolor abdominal crónico y constipación crónica. Se revisan los signos de alarma de la gastroenterología (ABC): anemia, baja de peso, cambio en los síntomas, disfagia, edad mayor de 50 años, antecedentes familiares de cáncer, antecedente de úlcera gastroduodenal, hemorragias y síntomas nocturnos. Ante su presencia, se debe realizar endoscopia o colonoscopia. El SII se diagnostica clínicamente con dolor abdominal crónico más alteraciones en consistencia o frecuencia de deposiciones, y alivio con la evacuación. El tratamiento incluye educación, manejo del estrés, y fármacos como amitriptilina (para diarrea) o trimebutino (para constipación).